AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS EM UROLOGIA CLÍNICA

PROVA TRANSCRIÇÃO INTEGRAL - 50 QUESTÕES

Nome do Aluno: _____

Nota/Conceito: _____

Assinatura: _____

Data: ____/____/_____

> **Instruções:** Esta avaliação contém 50 questões de múltipla escolha. Leia atentamente os enunciados de cada caso clínico e selecione a alternativa correta. Cada questão apresenta apenas uma resposta adequada.

Questão 1. G.G., Fem., 23 anos, refere há 1 dia ardor para urinar, polaciúria e dor supra púbica. Negava episódio semelhante no passado. Evoluiu com quadro de febre e calafrios. O exame de urina tipo I demonstra incontáveis leucócitos. Qual o provável diagnóstico:

a. Doença inflamatória pélvica aguda.

b. Litíase ureteral distal.

c. Cistite aguda.

d. Vulvovaginite.

e. Pielonefrite aguda.

Questão 2. M.C., Fem., 24 anos, na 32ª semana de gravidez, refere há 1 dia urina de cor mais escura, porém, assintomática, negava febre, e em ótimo estado geral. O exame de urina tipo I normal com cultura positiva: E. coli > 100.000 UFC/ml. Neste caso está CORRETO afirmar:

a. Como a paciente está assintomática, deve-se acompanhá-la ambulatorialmente.

b. Tratar a infecção de urina devido risco de trabalho de parto prematuro.

c. Interromper a gravidez imediatamente.

d. Fazer um ultrassom de vias urinárias.

e. Fazer uma tomografia computadorizada de abdômen sem contraste.

Questão 3. C.A., Fem., 66 anos diabética tipo II controlada com hipoglicemiante oral, sem outras comorbidades. Refere urina mau cheirosa, porém, assintomática e afebril. Nega alterações cognitivas. O EF geral normal. O exame ginecológico revelou ausência de corrimento vaginal com atrofia da mucosa vaginal ++/++++. O exame de urina tipo I normal e com cultura positiva: E. coli > 100.000 UFC/ml. Deve-se:

a. Iniciar antibioticoterapia imediata e reposição hormonal.

b. Solicitar ultrassom de vias urinárias.

c. Solicitar uma tomografia computadorizada.

d. Iniciar antibioticoterapia somente se a paciente apresentar sintomas urinários, alteração cognitiva ou dificuldade do controle do Diabetes.

e. Iniciar com insulina NPH e antibioticoterapia.

Questão 4. Paciente sexo feminino, 40 anos, há 3 dias iniciou quadro de polaciúria, ardor miccional, negava febre. EF em bom estado geral, temperatura de 36,8 graus, corada e hidratada, sem outras alterações. O exame ginecológico revelou atrofia vaginal +++/++++. O exame de urina tipo I com leucocitúria impedindo avaliação dos demais elementos. Deve-se:

a. Iniciar antibioticoterapia para gram-negativo, reposição hormonal tópica na região vaginal e acompanhamento ambulatorial.

b. Hospitalizar o paciente e iniciar antibioticoterapia sistêmica empírica para Gram negativo.

c. Hospitalizar o paciente e iniciar antibioticoterapia sistêmica com base no antibiograma.

d. Solicitar uma tomografia computadorizada e iniciar antibioticoterapia sistêmica com base no antibiograma.

e. Solicitar um ultrassom de vias urinárias e iniciar antibioticoterapia sistêmica com base no antibiograma.

Questão 5. Paciente sexo feminino com quadro clínico de pielonefrite aguda a esquerda comprovado pela história clínica, EF e exames laboratoriais. Foi iniciado antibioticoterapia sistêmica para Gram negativo, e após 48 horas vem mantendo febre e piora do estado geral, com função renal normal. Apesar do tratamento com antibiótico estar adequado segundo o antibiograma "in vitro". Qual a possível complicação e que exame de imagem solicitaria.

a. Escalonaria antibiótico para um melhor espectro + ultrassom de vias urinaria.

b. Escalonaria antibiótico para um melhor espectro + Tomografia computadorizada abdominal sem contraste.

c. Abcesso renal + ultrassom de vias urinaria.

d. Abcesso renal + urografia excretora.

e. Abcesso renal + Tomografia computadorizada abdominal com contraste.

Questão 6. Na cistite aguda, na mulher jovem, qual a fisiopatologia e o germe mais comumente encontrado:

a. Hematológica + Gram positivo.

b. Linfática + Gram negativo.

c. Ascendente + Gram negativo.

d. Ascendente + Fungo.

e. Hematológica + Gram negativo.

Questão 7. Na cistite aguda, na mulher jovem sem comorbidades, afebril, cujo exame de urina tipo confirmou incontáveis leucócitos, assinale a alternativa CORRETA:

a. Solicitar cultura de urina e após resultados iniciar antibioticoterapia.

b. Solicitar cultura de urina e iniciar antibioticoterapia para Gram negativo.

c. Antibioticoterapia para Gram negativo, sem solicitar urocultura.

d. Seguir ambulatorialmente e somente se tiver febre tratar com antibiótico.

e. Pedir Hemograma, função renal e urocultura e após iniciar antibioticoterapia.

Questão 8. Sobre o Trauma Renal, assinale a alternativa mais adequada:

1. São complicações tardias do trauma renal hipertensão arterial e hidronefrose.
2. Um trauma renal com lesão da via coletora e/ou extravasamento de urina deve ser classificado como grau V.
3. A hematúria é o sinal clínico mais comum e se correlaciona com a gravidade do trauma.
4. Crianças com trauma abdominal fechado e micro-hematúria devem permanecer sob avaliação clínica e exame físico seriado para descartar possível lesão renal.

a. Todas as afirmações acima estão corretas.

b. 1, 3 e 4 estão corretas.

c. 1, 2 e 4 estão corretas.

d. Apenas 1 e 4 estão corretas.

e. Todas as afirmações estão incorretas.

Questão 9. São fatores que contribuem para a maior incidência de Trauma Renal:

a. Presença de malformações renais como rim em ferradura.

b. Crianças.

c. Presença de hidronefrose.

d. Cistos renais volumosos.

e. Todas as anteriores.

Questão 10. Dentre as afirmações abaixo, a que melhor caracteriza a indicação para investigação do estudo radiológico no Trauma Renal é:

a. Todos os traumas em região de flanco independentemente de sua gravidade.

b. Traumas de qualquer natureza associados à hematúria macroscópica.

c. Traumas abdominais fechados em adultos com hematúria microscópica e PAS < 90mmHg.

d. Traumas abdominais associados à fratura de bacia.

e. Pacientes com rim único.

Questão 11. Com relação ao Trauma de Uretra, assinale a alternativa INCORRETA:

a. O melhor exame para diagnóstico do trauma de uretra é a uretrocistografia (UCM) pois, além de apresentar riqueza de detalhes, permite a classificação do trauma uretral.

b. Sangue no meato uretral (uretrorragia) é o sinal mais importante de lesão na uretra, tanto que, na sua ausência, pode-se indicar a sondagem retrógrada com segurança.

c. Lesões de uretra posterior podem estar associadas às fraturas de bacia e a traumas de alta energia, onde não é incomum a presença de lesões de outros órgãos pélvicos ou abdominais.

d. A maioria das lesões da uretra anterior são causadas por trauma perineal, onde a uretra é 'prensada' contra o pubis em um mecanismo clássico de trauma conhecido como 'queda a cavaleiro'.

e. A observação de próstata elevada ou deslocada ao toque retal é indicativo de trauma de uretra posterior.

Questão 12. Paciente de 16 anos, masculino, vítima de briga de torcida após jogo de futebol há cerca de 6 horas. Refere ter levado vários socos e pontapés no hipogástrio e que não apresenta micção espontânea desde então. Encaminhado ao PS consciente, orientado, nauseado, estável com FC=100 e PA= 140x90mmHg. Ao exame físico (dados positivos): escoriações apenas em baixo ventre, abdome ligeiramente distendido com diminuição dos ruídos hidroaéreos e dor à palpação difusa, com descompressão brusca dolorosa positiva. Giordano negativo. Ausência de hematoma perineal, uretrorragia ou bexigoma. Após o cateterismo vesical sem traumas ou dificuldades, observada presença de pequena quantidade de urina avermelhada no coletor (cerca de 20ml). Em relação a este paciente é CORRETO afirmar que:

a. Provável trauma renal e melhor conduta é a tomografia helicoidal sem contraste.

b. Provável trauma renal, mas devido à estabilidade clínica e ausência de hematúria, não há indicação de investigação radiológica no momento.

c. Trata-se de anúria obstrutiva (provável trauma de uretra) e a melhor conduta é a realização de cistostomia de urgência.

d. Provável trauma de bexiga intraperitoneal e a conduta mais adequada é a realização de uretrocistografia.

e. Provável trauma de bexiga e a conduta mais adequada é a realização de cistoscopia para documentar a extensão da lesão, seguida de sondagem uretral de demora para tratamento conservador.

Questão 13. Assinale a alternativa CORRETA em relação ao trauma vesical:

a. O trauma extraperitoneal pode ser tratado conservadormente com sondagem vesical de demora e observação clínica, mesmo nos casos de lesão múltipla associada à hematúria significativa, devendo-se, neste caso, instalar irrigação vesical contínua.

b. A uretrocistografia é considerada exame de escolha no diagnóstico quando da suspeita de trauma vesical.

c. A conduta mais adequada no trauma intraperitoneal de bexiga é a realização de cistostomia de urgência.

d. A presença de hematúria macroscópica no momento da sondagem uretral do paciente politraumatizado é um indicativo inequívoco de lesão vesical.

e. A lesão intraperitoneal, via de regra, deve ser tratada com cirurgia em todos os casos, devido a presença de sangue/ou urina na cavidade peritoneal.

Questão 14. No paciente politraumatizado com suspeita de lesão renal, cuja instabilidade hemodinâmica não pode ser alcançada satisfatoriamente com as medidas clínicas habituais (hidratação, transfusão, uso de drogas, etc), a conduta mais apropriada é:

a. Encaminhar o paciente para a tomografia, mesmo instável e solicitar celeridade no processo.

b. Encaminhar o paciente para tratamento de terapia intensiva (UTI) e aguardar 6 a 12 horas para estabilização.

c. Indicar laparotomia exploradora de urgência.

d. Solicitar serviço de hemodinâmica para tentar coibir o sangramento por embolização.

e. Proceder à nefrectomia de urgência por lombotomia visando minimizar ao máximo a perda sanguínea do paciente.

Questão 15. Sobre a Neoplasia de testículo é CORRETO afirmar que:

a. Os tumores não germinativos compõem 90% do tipo histológicos encontrados.

b. Os seminomas é o tipo histológico mais comum e em 10% das vezes o BHCG está aumentado.

c. A apresentação bilateral sincrônica é muito comum sendo a maioria dos casos.

d. As neoplasias germinativas não são rádios e quimiossensíveis em sua maioria.

e. A faixa etária mais envolvida é 4ª e 5ª de cada de vida.

Questão 16. Todos os casos abaixo são indicativos de biópsia de próstata para diagnóstico de neoplasia de próstata com exceção de:

a. 50 anos, PSA 3,2 ng/ml em 2023, L/T: 10%, PSA prévio de 2022: 2,0 ng/ml toque normal 20 gramas benigno.

b. Nódulo endurecido em ápice direito e PSA 13ng/ml.

c. 60 anos, próstata de 100cm³, com PSA 9ng/ml, L/T:26%, PSA prévio: 8,8ng/ml de 2022.

d. 54 anos, PSA total 5,6ng/ml, L/T=9% com EDR 40 gramas benigno.

e. 70 anos, PSA 17 ng/ml e EDR com próstata pétrea, sem limites e dolorosa.

Questão 17. Tratamento mais aceito atualmente para Neoplasia de próstata localmente avançado é:

a. Hormonioterapia.
b. Radioterapia.
c. Radioterapia e Hormonioterapia por 24 meses.
d. Prostatectomia Radical.
e. Quimioterapia sistêmica.

Questão 18. O tipo Histológico mais comum de neoplasia de próstata é:

a. Acinar.
b. Mucinoso.
c. Anel em sinete.
d. Pequenas células.
e. Neuroendócrino.

Questão 19. São indicações cirúrgicas de Hiperplasia de próstata (HPB) todas as indicações abaixo com exceção de:

a. Retenção urinária aguda.
b. Hematúria recorrente de origem prostática.
c. Insuficiência renal pós renal por obstrução infra vesical.
d. Infecção de trato urinário de repetição.
e. Índice de protusão prostática acima de 1,0cm no ultrassom supra púbico.

Questão 20. São considerados exames recomendáveis no acompanhamento de hiperplasia prostática benigna (HPB):

a. Cistoscopia e fluxometria.
b. PSA e cistoscopia.
c. Fluxometria e ultrassom supra púbico.
d. Cistoscopia e ultrassom supra púbico.
e. Uretrocistografia miccional e fluxometria.

Questão 21. Os locais mais comuns de metástase em neoplasia de próstata são em ordem de prevalência:

a. Osso, pulmão, cérebro.

b. Osso, fígado, pulmão.

c. Osso, pulmão, pele.

d. Fígado, pulmão e linfonodos.

e. Linfonodos, pulmão, fígado.

Questão 22. Qual patologia apresenta tal lesão cutânea:

[Imagem 22: Lesões Dermatológicas]
A imagem do exame original mostra lesões vesiculares agrupadas sobre base eritematosa na região peniana, típicas de infecção viral ativa.

a. Herpes simples.

b. Cancroide - Ducrey.

c. Molusco contagioso.

d. Chlamydia trachomatis.

e. HPV.

Questão 23. Um paciente, com vinte anos de idade, vítima de acidente com motocicleta, deu entrada no serviço de emergência com quadro de uretrorragia. No momento, apresenta quadro clínico estável e o exame clínico e neurológico é inocente. Os raios X de tórax, crânio e coluna são normais e o de bacia está ilustrado abaixo.

[Imagem 23: Radiografia de Bacia]
A imagem do exame original apresenta uma radiografia da bacia de um paciente masculino demonstrando fratura de ramos pubianos com desvio associado, caracterizando lesão traumática do anel pélvico anterior.

Com base no quadro clínico apresentado, é CORRETO afirmar que no próximo exame a ser realizado será:

a. Tomografia computadorizada.

b. Uretrocistografia retrógrada.

c. Urografia excretora.

d. Ultrassonografia de abdome total na sala de emergência.

e. Não há indicação de novos exames, apenas medidas de suporte e observação clínica.

Questão 24. Todas as afirmações abaixo estão corretas acerca do priapismo isquêmico (baixo fluxo), EXCETO:

a. Constituem formas possíveis de tratamento a embolização seletiva ou a ligadura cirúrgica da fístula arteriovenosa.

b. Trata-se de de urgência urológica.

c. O mecanismo básico envolvido nas diferentes etiologias possíveis é, em última instância, a corporoclusão ou a importante lentificação do fluxo sanguíneo no corpo cavernoso.

d. É bem mais frequente que o priapismo arterial ou de alto fluxo.

e. Dentre seus possíveis agentes causais destacam-se o uso e drogas vasoativas intracavernosas, diversos medicamentos como psicotrópicos, drogas ilícitas (Crack) e doenças hematológicas, entre outras.

Questão 25. Criança sexo feminino, 6 meses de idade, mãe refere que há 1 dia criança vem apresentando com febre de 39° C, não se alimentando bem. O exame físico revela criança hidratada, corada, febre 37,8° C, em regular estado geral, otoscopia e orofaringe normais. Ausculta pulmonar e exame de abdome normais. Apresenta Hemograma e creatinina normais. O exame de urina tipo I com incontáveis leucócitos. Qual a Hipótese Diagnóstica e melhor conduta:

a. Pielonefrite aguda e internar a paciente e iniciar antibiótico imediato para Gram -.

b. Cistite aguda e mandar para casa com tratamento com antibiótico para Gram +.

c. Pielonefrite aguda e internar a paciente e iniciar antibiótico imediato para Gram +.

d. Cistite aguda e mandar para casa com tratamento com antibiótico para Gram -.

e. Pielonefrite aguda e internar a paciente e iniciar antibiótico após o resultado da cultura com antibiograma.

Questão 26. O método radiológico de escolha para melhor avaliar a função renal em um paciente com história de pielonefrite de repetição associado com cirurgia percutânea renal para remoção de cálculo piélico é:

a. Urografia excretora.

b. Ressonância magnética.

c. Tomografia Helicoidal com contraste.

d. Ultrassom renal com doppler.

e. Cintilografia com DMSA.

Questão 27. Com relação à perfusão, "in situ" ou extra-corpóreas de um rim para transplante, assinale a alternativa mais CORRETA:

a. O resfriamento do órgão visa reduzir a taxa do metabolismo celular e consumo de oxigênio a níveis mínimos, além da remoção do sangue da micro-circulação evitando assim a trombose dos capilares renais.

b. Utiliza solução hipo-osmolar especialmente preparadas para minimizar ao máximo os danos teiduais.

c. Nenhuma das acima mencionadas porque o objetivo da perfusão é a inibição total metabolismo celular, razão pela qual o rim deve ser imerso em gelo até o momento do transplante.

d. A e B estão corretas.

e. Visa a dessensibilização das células renais, diminuindo assim as chances de rejeição do órgão após o implante no receptor.

Questão 28. Assinale a alternativa INCORRETA em relação ao câncer de pênis:

a. Em geral é mais prevalente em regiões mais pobres como nordeste do Brasil.

b. Apresenta-se inicialmente como lesão ulcerada de difícil cicatrização.

c. A amputação peniana constitui-se a única forma de tratamento curativo.

d. O principal sítio de metástase são os linfonodos das regiões inguinais superficiais.

e. O carcinoma espinocelular constitui-se o tipo histológico mais comum.

Questão 29. Em relação a infecção urinária febril em criança assinale a INCORRETA:

a. O refluxo vesico ureteral pode ser um dos principais motivos.

b. Está relacionada com ureterohidronefrose unilateral.

c. Está relacionada com o sexo feminino.

d. Tem necessidade de internação hospitalar.

e. Pode apresentar cicatrizes renais após o tratamento adequado.

Questão 30. Sobre a fimose, assinale a alternativa CORRETA:

a. Realizar postectomia após os 5 anos de idade.

b. Adulto pode desenvolver fimose.

c. Fazer massagem diariamente para ter bons resultados clínicos.

d. Se não operar quando criança pode levar a déficit de desenvolvimento peniano.

e. Sempre iniciar com o tratamento com pomada.

Questão 31. A alternativa VERDADEIRA no caso de parafimose:

a. Realizar a postectomia de imediato.
b. Normalmente associado com infecção urinária.
c. A maioria dos casos resolve com anti-inflamatório e gelo.
d. Poucos casos são de origem iatrogênica.
e. A redução do prepúcio é o tratamento inicial.

Questão 32. A hidronefrose ante natal, qual seria as orientações para a futura mãe:

a. E caso de hidronefrose unilateral, a dilatação renal pode prejudicar o funcionamento do rim contra lateral.
b. Há necessidade de intervenção intra útero para minimizar a perda renal futura.
c. Após o nascimento deve se solicitar a tomografia computadorizada para avaliar a hidronefrose.
d. A hidronefrose sempre é cirúrgica e deve ser operado o mais rápido possível.
e. NDA.

Questão 33. Em relação a infecção urinária, assinale a alternativa CORRETA:

a. A bacteriúria assintomática deve ser tratada nas crianças do sexo feminino.
b. A pielonefrite aguda tanto em criança e adulto deve ser internada.
c. Sempre realizar o exame de urina tipo I para tratar infecção urinária.
d. A urocultura é o melhor exame para o diagnóstico.
e. A infecção urinária é mais comum no sexo feminino em qualquer faixa etária.

Questão 34. Sobre a balanopostite assinale a CORRETA:

a. Tratamento é cirúrgico.
b. Só ocorre em criança.
c. Sempre acompanhado de fimose.
d. Não usar medicamento via oral.
e. NDA.

Questão 35. Pielonefrite em criança. Assinale a INCORRETA:

a. Maioria relacionada com baixa imunidade e falta de higiene.
b. E. coli é o agente mais comum.
c. É considerada pielonefrite complicada e deve ser internada.
d. Deve ser sempre investigada para malformação do trato urinário.
e. Tratamento com antibiótico endovenoso.

Questão 36. Sobre o transplante renal. Assinale a INCORRETA:

a. A primeira avaliação para compatibilidade para transplante renal é o sistema ABO.

b. As 2 principais patologias que levam a perda renal no Brasil é a hipertensão arterial e diabetes.

c. A chance do doador renal desenvolver insuficiência renal após doar o rim é semelhante à população normal.

d. O transplante renal é o melhor tratamento para Insuficiência renal terminal, em comparação com a hemodiálise.

e. Paciente não pode fazer o segundo ou terceiro transplante renal em caso de rejeição.

Questão 37. Em relação ao escroto agudo, são verdadeiras, EXCETO:

a. É situação de urgência relativa, podendo ser avaliado em até 24 a 48 horas a partir do início de sua apresentação, com baixo risco de comprometimento funcional ao testículo.

b. Apresenta como diagnósticos diferenciais: torção testicular, torção de hidátide, hérnia inguinal, púrpura de Henöch-Schölein, trauma genital, hidrocele aguda, entre outros.

c. A avaliação clínica pode ser suficiente para a definição de conduta, prescindindo de exames complementares adicionais.

d. O principal diagnóstico a ser detectado é de torção testicular aguda, devido potencial risco de perda do órgão por isquemia.

e. Pode ocorrer em qualquer faixa etária, embora mais comum na puberdade.

Questão 38. A apresentação típica da torção testicular inclui todas as opções abaixo, EXCETO:

a. Dor escrotal unilateral, intensa e súbita.

b. Náuseas e/ou vômitos.

c. Horizontalização do testículo acometido.

d. Exacerbação do reflexo cremastérico ipsilateral.

e. Testículo acometido mais alto na bolsa que o contralateral.

Questão 39. Durante cirurgia de exploração escrotal por escroto agudo, com achado intra-operatório de torção testicular, as seguintes medidas podem ser necessárias:

a. Remoção do testículo.

b. Reversão da torção, com preservação testicular.

c. Fixação do testículo acometido.

d. Fixação do testículo contralateral.

e. Todas as anteriores.

Questão 40. Em paciente com testículo não-palpável unilateral:

a. A correção cirúrgica deve ser indicada até os cinco anos de idade.

b. Sua principal complicação é o desenvolvimento de dor abdominal ao longo da vida.

c. Há correlação com desenvolvimento de infertilidade, mas transformação maligna é incomum em comparação a um testículo normal.

d. A laparoscopia é o procedimento diagnóstico de escolha, sendo também terapêutico.

e. O primeiro passo na investigação seria com ultrassonografia inguinal + abdominal, de modo a permitir a localização do testículo.

Questão 41. Quanto ao procedimento de orquidopexia:

a. É sempre realizado pela via laparoscópica.

b. Pode ser realizado em tempo cirúrgico único, ou em dois tempos separados (Fowler-Stephens).

c. Não é indicado em casos de criptorquidia bilateral, dando-se preferência a tratamento hormonal como primeira escolha.

d. Testículo retrátil é uma indicação precisa.

e. Consiste na ligadura do ducto deferente, para liberar o testículo e permitir sua mobilização até o escroto.

Questão 42. NÃO é uma possível complicação ou consequência de fimose:

a. Infecção do trato urinário.

b. Balanopostite.

c. Parafimose.

d. Hidronefrose bilateral.

e. Enurese noturna.

Questão 43. Em relação à presença de fimose, na infância:

a. Na ausência de complicações, a postectomia deve ser evitada abaixo dos três anos de idade, uma vez que a maior parte dos meninos apresenta melhora espontânea do quadro até então.

b. Sucesso do tratamento conservador com esteroides tópicos não guarda relação clara com o grau da fimose.

c. Infecção urinária de repetição apenas necessita investigação adicional no caso de continuar ocorrendo mesmo após realizada a circuncisão.

d. A tentativa forçada de exposição da glande deve ser incentivada, como forma de se tentar evitar tratamento cirúrgico.

e. Sempre necessita tratamento, mesmo na ausência de sintomas, para evitar ocorrência de complicações.

> **Caso Clínico de Referência (Questões 44 a 46):**
> J. G., 51 anos, masculino, casado, Botucatu. Há 3 horas com dor lombar à direita de forte intensidade, em cólica, associada a náuseas e vômitos. AP. Vários episódios similares nos últimos 8 anos.

Questão 44. Qual das afirmativas abaixo seria o diagnóstico MENOS provável:

a. Calculose renal.
b. Colicistite aguda.
c. Lombalgia aguda.
d. Calculose biliar.
e. Calculose ureteral.

Questão 45. Das complicações da litíase renal. Qual seria a mais preocupante:

a. Dor incoercível.
b. Cristalúria.
c. Hematúria.
d. Infecção secundária.
e. Náuseas e vômitos.

Questão 46. Sobre exames de imagens é CORRETO afirmar:

a. A tomografia computadorizada sem contraste não visualiza cálculos radio-transparentes.
b. O RX simples é tão eficiente quanto o ultrassom para diagnóstico.
c. A ressonância magnética é superior a tomografia.
d. O ultrassom não visualiza cálculos no ureter médio.
e. A urografia excretora tem eficiência similar a tomografia.

Questão 47. Sobre o tratamento de litíase é CORRETO afirmar:

a. A litotripsia extracorpórea é contra-indicada em cálculos radiotransparentes.
b. A litotripsia extracorpórea pode ser realizada em pacientes anticoagulados.
c. Litotripsia extracorpórea está indicada para cálculos piélicos menores que 2cm.
d. A litotripsia extracorpórea não pode ser realizada em cálculos vesicais.
e. A litotripsia extracorpórea tem morbidade maior que a litotripsia percutânea.

Questão 48. Sobre o tratamento de litíase é CORRETO afirmar:

a. O uso de duplo J é a conduta preferencial para pacientes com cólica incoercível.
b. O uso de duplo J é a conduta preferencial para pacientes com infecção urinária secundária.
c. O uso de alfa-bloqueadores facilita a passagem de cálculo pela uretra.
d. O uso de alfa-bloqueadores diminui o peristaltismo ureteral.
e. O uso de escopolamina aumenta a eliminação espontânea do cálculo.

Questão 49. Sobre o tratamento de litíase na gestante é CORRETO afirmar:

a. O uso de antiinflamatório não esteroide por tempo prolongado é seguro.
b. Está indicado o uso de alfa-bloqueador na terapia expulsiva.
c. A ureteroscopia com litotripsia a laser é a indicação preferencial no primeiro trimestre.
d. Nos casos de infecção está indicado o uso de Duplo J.
e. A litotripsia extracorpórea é uma indicação segura.

Questão 50. No tratamento da litíase em paciente com rim contralateral normal NÃO é a melhor opção:

a. Nefrectomia para cálculo coraliforme em rim com DSMA de 30%.
b. Nefrolitotomia percutânea para cálculo piélico com 3 cm.
c. Litotripsia a laser com ureteroscópio flexível para cálculo de 1 cm em cálice inferior.
d. Litotripsia extracorpórea para cálculo em cálice superior com 1,5cm.
e. Ureterolitotomia laparoscópica para cálculo ureteral em terço médio de 0,5cm.

APÊNDICE: GABARITO DA PROVA ORIGINAL

Abaixo consta a chave de respostas (gabarito) correspondente às marcações à caneta identificadas na cópia do documento original analisado.

1	E	**11**	A	**21**	B	**31**	E	**41**	B
2	B	**12**	D	**22**	A	**32**	E	**42**	E
3	D	**13**	E	**23**	B	**33**	D	**43**	A
4	A	**14**	C	**24**	A	**34**	E	**44**	B
5	E	**15**	B	**25**	C	**35**	A	**45**	D
6	C	**16**	C	**26**	E	**36**	E	**46**	E
7	C	**17**	C	**27**	D	**37**	A	**47**	C
8	B	**18**	A	**28**	C	**38**	D	**48**	B
9	E	**19**	E	**29**	D	**39**	E	**49**	D
10	C	**20**	C	**30**	B	**40**	D	**50**	E

Nota: O gabarito acima foi extraído estritamente a partir das anotações manuscritas (sinais gráficos e caneta azul/roxa) presentes no documento original fornecido.